



ANNALES OFFICIELLES EVC

EVCP 2017

Épreuve de vérification des connaissances pratiques

Médecine générale (code 71)

SUJETS

4

QUESTIONS

26

SUJET

01

Cas clinique · 7 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Patient de 65 ans, retraité depuis quelques mois. Antécédents et facteurs de risque : surpoids, IMC à 29, tabagisme à 25 paquets/années interrompu il y a 10 ans, HTA traitée par Prazosine. La famille l'amène aux urgences car lors petit déjeuner (90 minutes plus tôt), il a présenté des troubles de l'élocution et a lâché son bol. Vous constatez qu'il est héli-parétique à droite et aphasique.

1

QUESTION 1

Quel diagnostic évoquez-vous en premier ?

2

QUESTION 2

Quel examen complémentaire faut-il réaliser ?

3

QUESTION 3

En l'absence d'hémorragie, quelle stratégie de prise en charge proposez-vous ?

4

QUESTION 4

La pression artérielle est alors à 155/85 mm Hg : que faites-vous ?

5

QUESTION 5

Pourquoi faut-il réaliser un ECG ?

6

QUESTION 6

Comment le résultat (de l'ECG) peut-il orienter votre prise en charge ?

7

QUESTION 7

Vous le revoyez en consultation un mois plus tard. Il a toujours le même traitement. Sa pression artérielle est à 155/85 (confirmée par auto-mesures). Que proposez-vous ?

SUJET

02

Cas clinique · 7 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Vous recevez aux Urgences Mr G, 85 ans, adressé pour chute au domicile. Son aide ménagère a appelé les pompiers en le découvrant au sol dans ses toilettes, ce matin, Constantes à l'arrivée : TA 105/65 mmHg, pouls 110 BPM, température auriculaire 37,5°, Saturation 92% (air ambiant). Il est désorienté sans signe méningé ni de localisation neurologique. L'électro-cardiogramme est normal hormis une tachycardie sinusale. Vous contactez son médecin traitant qui vous détaille ses antécédents : Ethylo- tabagisme chronique -HTA- Dépression Ainsi que ses traitements : Perindopril 4mg/j - Nicardipine 50 mg/12H - Hydrochlorothiazide 25mg/j (ajout récent en raison d'une HTA insuffisamment contrôlée.) Paroxétine 20mg/j - Bromazepam 6mg/j - Aspirine 75MG/J

1

QUESTION 1

Quelles sont les 3 principales causes de chute à évoquer chez ce patient?

2

QUESTION 2

Il n'a pas pu se relever seul. Vous notez une ecchymose frontale et il ressent une douleur fessière. Quel (s) examen (s) d'imagerie demandez-vous ? Justifiez.

3

QUESTION 3

Le patient continue à présenter des troubles cognitifs malgré la normalité des examens d'imagerie. Suggérez 2 éléments à vérifier à l'examen clinique.

4

QUESTION 4

Voici ses premiers résultats biologiques : Leucocytes $9,8 \times 10^9/L$ - Hémoglobine 9,4g/dl - VGM 75 fl Globules rouges $3,5.10^{12}/L$ - Plaquettes $350.10^9/L$ - Sodium 120 mmol Potassium 4,8 mmol- Chlore 87 mmol - Bicarbonates 24 mmol - Urée 15 mmol - Créatinine 212 μmol - Glucose 5,5 mmol - Calcium 2,2 mmol - Protides 65 g/L -CPK 5200 Ui/L. Quelles anomalies significatives identifiez vous ?

5

QUESTION 5

Quelles sont les causes possibles de l'anomalie du ionogramme sanguin ?

6

QUESTION 6

Le patient est hospitalisé en service de médecine pour rééquilibration hydro-électrolytique. Quelle (s) classe (s) médicamenteuse (s) utilisez vous pour l'anti coagulation prophylactique ?

7**QUESTION 7**

Après 3 jours d'hospitalisation, l'infirmière vous signale avoir découvert un méléna dans le lit du patient. A la gastroscopie, quelles sont les 3 anomalies que vous vous attendez à observer de façon la plus probable ?

SUJET

03

Cas clinique · 6 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 70 ans se plaint d'une douleur d'apparition brutale de la base thoracique gauche associée à une dyspnée. Dans les antécédents on note une hypertension artérielle bien équilibrée sous amlodipine, un diabète de type 2 traité par sulfamides hypoglycémiants, un polype colique réséqué et une gonarthrose. Il existe un tabagisme actif. L'examen clinique montre une température à 38,0°C, une fréquence cardiaque régulière à 95/min, une saturation en oxygène au doigt à 92% (en air ambiant) et une tension artérielle à 154/91 mmHg.

1

QUESTION 1

Quelles sont les 3 hypothèses diagnostiques que vous devez évoquer ?

2

QUESTION 2

Dans l'hypothèse d'une embolie pulmonaire, quel examen permet de confirmer ce diagnostic ?

3

QUESTION 3

L'embolie pulmonaire est confirmée. Quel bilan pré-thérapeutique prescrivez-vous ?

4

QUESTION 4

Dans l'hypothèse où le bilan pré- thérapeutique est normal, quel type de traitement anticoagulant prescrivez-vous d'emblée ?

5

QUESTION 5

Dans l'hypothèse où l'hémogramme montre un taux d'hémoglobine de 9,7 g/dl avec un VGM à 74 fl. Quels éléments d'interrogatoire cherchez-vous compte tenu de ce résultat ?

6

QUESTION 6

Dans ce contexte d'anémie microcytaire, quel est le diagnostic le plus probable ? Quel examen demandez-vous pour le confirmer ?

SUJET

04

Cas clinique · 6 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 45 ans est amené aux urgences par les pompiers suite à une chute sur la voie publique. Il présente une plaie du scalp. On note plusieurs passages aux urgences cette année dans des circonstances identiques. Il a comme ATCD des séjours en hospitalisation psychiatrique et un traitement injectable retard mensuel haloperidol* 4 ampoules, administré en centre médico psychologique. Il est actuellement au chômage. Il vit en foyer d'hébergement d'urgence. A son arrivée, on retrouve une plaie du cuir chevelu de 5 cm; il est logorrhéique, et tient des propos familiers. La pression artérielle est de 130/80 mm, le pouls est à 90/min. la température à 37,6. La saturation en oxygène de 96%. L'éthylomètre pratiqué est de 0.8 en air expiré.

1

QUESTION 1

Six heures après son admission aux urgences, l'infirmière vous appelle pour une crise convulsive, en phase de récupération. A ce stade, que demandez-vous comme investigations indispensables sachant que votre examen clinique est normal ?

2

QUESTION 2

Les examens complémentaires sont normaux. Quelques heures plus tard, le patient s'agite, hurle, dit qu'il voit son chien aboyer dans la pièce et qu'il faut lui donner à manger. La température est de 38°6, le pouls à 120 min, la tension artérielle à 180/120. L'examen clinique est toujours sans particularités. Quels sont les principaux diagnostics à poser ?

3

QUESTION 3

Que prescrivez-vous comme traitement en première intention ?

4

QUESTION 4

Le diagnostic de Gayet Wernicke est posé chez ce patient dans les suites de l'hospitalisation. Quelles sont les trois principaux signes cliniques qui évoquent ce diagnostic ?

5

QUESTION 5

Quel est le traitement à préconiser dans le syndrome de Gayet Wernicke ?

6

QUESTION 6

a/ En l'absence de traitement, quelle peut être l'évolution à terme de ce syndrome ? b/ Quels en sont les trois principaux signes cliniques ? Médecine

générale\EVCP.71.DOC Page : PAGE NUMPAGES

öêþxİÇþ»~šŸ-Ÿœ,,œ,,œvœenvcvV/Lvcv h-gŸ h¹¼\O h6uñ háy9 hâA§ hKQ hg0¾4

gda gd6uñ óéÛĐÛóéÛĐÛóéÛĐÛóÆóéÛĐÛó'¬æ™¬¬†~†~v~n~nh½&h,J|h¹kA

hƒoÈ gdáy9 gd¹kA õíaÒÆ´¥õ-œ„|„gfXœ„|„MXœqE„ h[t0 gd,| gdQ# gd½&

øêâøâÔâÔâlâlâlâlâlâlÀlÀlÀlÀlÀlÀlÄ¹®!"OE sÄÄ hQ# h~ZU

øðèðÝÒÄð¼ðèðÝ±žžt`UHt h(; hH5z õåÚí»®¼®åžáí,,íáízáírbjWjL hÇ)³htp%.

häu•gdàVîgd†p%òçbíÅ½2§™ŽÅ§™ŽÅ€§€ÅŽ§™§ŽÅŽ§™§™§ÅŽ™umim h.4Z

hàVÍgdTe8 gdÇ)³ öîêàÚàïàÚàÚàïàêËÀ hû ' hãA^ °, °ÆA!°% A@òÿ; ÿÿÿÿ

[illegible]

ODONTOLOGIE`zÿ%àz[,9Ó"sù69ÓŒŒœ.+,ù®0ProdiserTitreþÿÿÿ#þÿÿÿ<

p̣ỵỵỵD p̣ỵỵỵỵỵM

[illegible]

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

p

Amino Acid	Frequency (%)
Glycine	7.6
Alanine	8.3
Valine	6.9
Leucine	6.9
Isoleucine	6.9
Proline	5.8
Serine	5.8
Threonine	5.8
Asparagine	5.8
Glutamine	5.8
Aspartic acid	5.8
Glutamic acid	5.8
Lysine	5.8
Arginine	5.8
Histidine	5.8
Phenylalanine	5.8
Tyrosine	5.8
Tryptophan	5.8
Cysteine	5.8
Methionine	5.8
N-terminal	5.8
C-terminal	5.8

Document Microsoft Word MSWordDoc 092a